

1. Introducción y relevancia clínica

La **enfermedad de Ménière (EM)** es un **trastorno crónico del oído interno**, caracterizado por episodios recurrentes de **vértigo rotatorio**, **hipoacusia fluctuante**, **tinnitus** y **sensación de plenitud auricular**.

Corresponde a una **hidrops endolinfático idiopático**, es decir, una **distensión patológica del compartimento endolinfático** del laberinto membranoso.

Fue descrita por **Prosper Ménière en 1861**, quien postuló que el vértigo podía originarse en el oído interno, y no en el cerebro, como se creía hasta entonces.

Relevancia clínica

- Es una de las **principales causas de vértigo periférico recurrente** en adultos.
- Genera **discapacidad importante** por la intensidad y frecuencia de las crisis.
- Puede evolucionar hacia **hipoacusia progresiva y bilateral**.
- En Chile, tiene impacto relevante en población laboral activa y adultos mayores.
- Su diagnóstico y manejo precoz permiten mejorar la calidad de vida y prevenir secuelas auditivas.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

2.1 Anatomía funcional del oído interno

El oído interno contiene dos líquidos:

- **Perilinf** (en el laberinto óseo): rica en sodio (Na^+).
- **Endolinf** (en el laberinto membranoso): rica en potasio (K^+).

El equilibrio entre ambos compartimentos mantiene la excitabilidad de las células ciliadas sensoriales de la cóclea y los canales semicirculares.

2.2 Hidrops endolinfático

En la enfermedad de Ménière existe una **acumulación excesiva de endolinfa**, que distiende el laberinto membranoso (sáculo, utrículo y cóclea).

Esta distensión puede romper la membrana de Reissner, mezclando perilinfa y endolinfa, lo que altera el potencial eléctrico coclear y vestibular, generando los síntomas característicos.

2.3 Causas y factores asociados

Aunque su etiología exacta es desconocida, se han propuesto varios mecanismos:

- **Idiopática** (la mayoría de los casos).
- **Autoinmunidad del oído interno.**
- **Trastornos vasculares o isquemia coclear.**
- **Infecciones virales previas.**
- **Alergias alimentarias o ambientales.**
- **Factores genéticos** (formas familiares descritas).

Factores desencadenantes: estrés, exceso de sal, cafeína, alcohol, tabaquismo.

3. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

3.1 Cuadro clínico clásico

La enfermedad de Ménière presenta una **tétrada característica**:

Síntoma	Descripción
Vértigo rotatorio	Intenso, recurrente, de inicio súbito, dura 20 minutos a 12 horas. Asociado a náuseas, vómitos y desequilibrio.

Hipoacusia neurosensorial	Fluctuante al inicio, afecta frecuencias bajas y medias. Con el tiempo se vuelve permanente.
Tinnitus	Zumbido grave o ensordecedor, suele aumentar antes o durante las crisis.
Plenitud aural	Sensación de presión u oído tapado previo a las crisis.

Entre los episodios, el paciente puede quedar con hipoacusia leve o tinnitus residual.

3.2 Evolución natural

- Fases iniciales: crisis vertiginosas con recuperación completa.
- Fases tardías: hipoacusia progresiva y disminución del vértigo (por degeneración vestibular).
- Puede volverse **bilateral en 20–40%** de los casos a lo largo de los años.

3.3 Diagnóstico diferencial

Diagnóstico	Diferencias clave
Vértigo posicional paroxístico benigno (VPPB)	Episodios breves (segundos), gatillados por movimientos cefálicos, sin hipoacusia.
Neuronitis vestibular	Vértigo prolongado (>24 h), sin hipoacusia ni tinnitus.
Migraña vestibular	Historia de migraña, sin pérdida auditiva.

Fístula perilinfática	Vértigo post-esfuerzo o trauma, con hipoacusia súbita.
Tumor del ángulo pontocerebeloso (neurinoma)	Hipoacusia progresiva unilateral, sin vértigo paroxístico.

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

4.1 Diagnóstico clínico (criterios de la AAO-HNS, 2015)

Diagnóstico de enfermedad de Ménière definida requiere:

1. **≥2 episodios espontáneos de vértigo rotatorio** de 20 minutos a 12 horas.
2. **Hipoacusia neurosensorial documentada** (audiometría) en al menos una ocasión.
3. **Tinnitus o plenitud aural** asociados al oído afectado.
4. Exclusión de otras causas vestibulares.

Probable: si hay vértigo recurrente con síntomas auditivos fluctuantes sin audiometría confirmatoria.

4.2 Exámenes complementarios

Examen	Utilidad
Audiometría tonal liminar	Pérdida sensorineural, frecuencias bajas al inicio, luego global.
Impedanciometría	Normal o con reflejos estapediales ausentes.
Electrococleografía	Aumento de la relación SP/AP (>0,4) sugiere hidrops endolinfático.

**Pruebas vestibulares
(VNG, vHIT)**

Hiporreflexia vestibular unilateral.

**RM con gadolinio (oído
interno)**

Excluye neurinoma o lesiones estructurales. Puede visualizar hidrops en secuencias especiales.

5. Tratamiento (según guías MINSAL / Chile)

El objetivo es **disminuir la frecuencia e intensidad de las crisis, preservar la audición y mejorar la calidad de vida.**

5.1 Tratamiento médico

A. Medidas generales y educación

- Reducción de **sal en la dieta (<2 g/día).**
- Evitar **cafeína, alcohol y tabaco.**
- Control del **estrés y ansiedad** (frecuente factor desencadenante).
- Dormir adecuadamente y mantener hidratación.

B. Tratamiento farmacológico de mantenimiento

1. **Betahistina (Serc®):**

- 16–24 mg VO cada 8–12 horas.
- Favorece microcirculación del oído interno.
- Uso prolongado (meses).
- Bien tolerada.

2. **Diuréticos tiazídicos (hidroclorotiazida ± triamtereno):**

- Disminuyen presión endolinfática.
- Control de electrolitos durante uso prolongado.

3. **Corticoides sistémicos o intratimpánicos** (en crisis persistentes o refractarias):

- Prednisona 1 mg/kg/día por 7–10 días.
- Alternativa: inyección intratimpánica de dexametasona (4 mg/ml).

5.2 Tratamiento de la crisis aguda

Fármaco	Dosis / vía	Efecto
Betahistina VO	24 mg cada 8 h	Reduce intensidad del vértigo
Benzodiacepinas (diazepam 5–10 mg VO/IV)	Sedante vestibular y ansiolítico	
Antieméticos (metoclopramida, dimenhidrinato)	Control de náuseas y vómitos	
Reposo en cama	Durante el episodio agudo	

Duración típica: 1–12 horas.

Evitar movimientos bruscos y luces intensas.

5.3 Tratamiento quirúrgico y procedimientos en casos refractarios

Procedimiento	Indicación	Observaciones
Infiltración intratimpánica de gentamicina	Casos refractarios con vértigo incapacitante	Abla vestibular controlada, puede causar hipoacusia adicional.

Descompresión del saco endolinfático	Preservar audición, reducir vértigo	Técnica conservadora.
Neurectomía vestibular selectiva	Vértigo severo con audición útil	Riesgo quirúrgico neurológico.
Labirintectomía	Audición ya no útil	Elimina vértigo pero produce sordera completa.

6. Complicaciones y pronóstico

Complicación	Descripción
Hipoacusia progresiva	Secuela más frecuente. Bilateral en hasta 40%.
Caídas súbitas (“drop attacks”)	En fases avanzadas, por pérdida brusca del control postural.
Ansiedad y depresión	Por incertidumbre y limitaciones sociales/laborales.
Discapacidad auditiva permanente	En hipoacusia irreversible.

Pronóstico:

- En fases iniciales, control adecuado en >70% con manejo médico.
 - Vértigo tiende a disminuir con el tiempo; hipoacusia progresa.
 - Menor recurrencia con control dietético y farmacológico adecuado.
-

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

Perlas clínicas

1. **Vértigo + hipoacusia fluctuante + tinnitus = Enfermedad de Ménière.**
 2. Las crisis duran **minutos a horas (no segundos ni días).**
 3. Afecta primero **frecuencias bajas** en la audiometría.
 4. **Betahistina y dieta hiposódica** son pilares del tratamiento.
 5. Si el vértigo es **incapacitante y refractario**, se indica **gentamicina intratimpánica**.
 6. Con el tiempo, el vértigo disminuye, pero la **hipoacusia puede empeorar**.
-

Errores comunes

- Diagnosticar Ménière ante cualquier vértigo con tinnitus, sin audiometría.
 - Usar betahistina solo durante las crisis (debe ser de mantenimiento).
 - No indicar reducción de sal y cafeína.
 - No descartar causas secundarias con RM (neurinoma, esclerosis múltiple).
 - Indicar cirugía precoz sin agotar manejo médico.
-

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. La **enfermedad de Ménière** es un **hidrops endolinfático idiopático**, con crisis recurrentes de vértigo, tinnitus, plenitud y hipoacusia fluctuante.
2. Los episodios duran **20 minutos a 12 horas** y pueden causar **náuseas y vómitos intensos**.
3. La **audiometría** muestra hipoacusia sensorineural en **frecuencias bajas** al inicio.
4. El **tratamiento inicial** incluye **betahistina, dieta hiposódica y diuréticos tiazídicos**.

5. En crisis, usar **antieméticos y benzodiacepinas**.
6. En casos refractarios, se considera **gentamicina intratimpánica o cirugía**.
7. El vértigo mejora con el tiempo, pero la **hipoacusia puede volverse permanente**.